

УДК: 616-006.6

М.Е.Мамаев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Качество онкологической помощи в контексте обеспеченности современным высокотехнологическим оборудованием

Аннотация. Реализуемые инвестиционные проекты в рамках выполнения Государственной программы развития здравоохранения (ГПРЗ) Республики Казахстан (РК) «Саламатты Қазақстан» на 2011 - 2015 годы направлены на повышение качества оказания медицинских услуг.

В Республике Казахстан принята отраслевая Программа развития онкологической помощи (ПРОП) на 2012-2016гг. В ходе реализации ПРОП планируется освоение масштабных бюджетных средств, в связи, с чем необходимо внедрение системы прогнозирования, оценки и управления рисками, внедрение методик экономического анализа деятельности системы здравоохранения, переход на систему контроля, основанную на внедрении принципов непрерывного улучшения качества принятия управленческих решений (CQI - PDCA).

Мониторинг инвестиционной деятельности, управления инвестиционными проектами в системе здравоохранения РК является важным составляющим инструментом для достижения поставленной цели и задач

Ключевые слова: . Онкологическая помощь, высокие технологии, внедрение системы

Введение

В государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы определены цель, задачи и пути их достижения [1]. Большое значение уделяется улучшению качества медицинских услуг и развитию высокотехнологичной системы здравоохранения. поэтапный перевод медицинских организаций в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения направлен на совершенствование системы управления, финансирования, инвестиционной политики в здравоохранении, повышение экономической эффективности деятельности медицинских организаций и решение вопросов кадрового обеспечения.

Н.А. Назарбаев в Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства подчеркнул, что «экономическая политика нового курса - всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности», т.е. освоение средств, реализация инвестиционных проектов во всех секторах экономики должно иметь принцип целесообразности. В условиях существенного увеличения государственного финансирования в здравоохранении, появления новых эффективных методов управления в области

здравоохранения, растущих цен на современное медицинское оборудование, важно выполнить поставленные задачи и вызовы современного мироустройства путем совершенствования организации, управления и финансирования медицинской помощи.

С целью повышения ожидаемой продолжительности и качества жизни граждан страны путем снижения смертности населения от онкологических заболеваний в лице ответственного за исполнение и разработчика Министерства здравоохранения Республики Казахстан реализуется Программа развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы. На реализацию Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан будут направлены средства республиканского и местных бюджетов.

Совершенствование современной системы управления качеством медицинской помощи (МП) на уровне субъекта здравоохранения – это важный рычаг повышения качества МП.

Основы теории концепции непрерывного повышения качества в здравоохранении были заложены доктором Avedis Donabedian. Выделены три главных направления работы по управлению качеством медицинской помощи – совершенствование структуры, процесса и результата. Взаимосвязь структуры, процесса и результата получила название «триады Донабедиана». По А.Донабедиану, качество медицинской помощи определяется использованием медицинской науки и технологии с наибольшей выгодой для здоровья человека, при этом без увеличения риска.

В эпоху глобализации, повсеместной интеграции во всех общественно-экономических отношениях, всеобщего быстрого темпа развития высоких технологий и активного внедрения во все сферы человеческой деятельности, важно отметить неотъемлемую, значительную ее роль в повышении и управлении качеством оказания медицинских услуг, основанных на концепции непрерывного повышения качества. При этом важно учитывать рост затрат на их внедрение и глобальный тренд повышения цен в «Новой экономической реальности». Казахстану нужна модернизация системы управления государственными активами. Страна должна работать, как единая корпорация, а государство должно быть ее ядром. Казахстан, по сравнению с нашими соседями - дальними и ближними, - небольшое государство как по объему экономики, так и по объему, в целом, страны и населения. Поэтому, как корпорация, компания управляет своим хозяйством, каждый день вкладывает деньги и старается получить от них прибыль, вот так же, как одна корпорация, мы должны научиться управлять нашей страной», что придает новый

импульс в развитие проектно-ориентированного подхода в реализации государственных мероприятий и интеграции бизнес и государственных моделей управления с применением новых подходов в принятии решений [2].

Согласно ГПРЗ Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015гг. продолжится поэтапное внедрение института профессиональных менеджеров и транспарентных форм управления организациями здравоохранения, включая современные управленческие технологии; планируется внедрение системы прогнозирования, оценки и управления рисками; внедрение методик экономического анализа деятельности системы здравоохранения (создание системы оценки эффективности отрасли); переход на систему контроля, основанную на внедрении принципов непрерывного улучшения качества, принятие управленческих решений (CQI – PDCA) и разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий управления [1].

В аналитической записке (2011г.) о реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года отмечается, что в условиях стабильного финансирования отрасли стало возможным начать внедрение высоких технологий и новых методов диагностики в регионах.

Отмечается положительная динамика роста внедрения медицинских технологий при оказании медицинской помощи: в 2010 году было внедрено 65 новых технологий диагностики и лечения, в 2011 году - 123. Констатируется положительная динамика и в обеспечении физической (географической) доступности медицинской помощи: сегодня высокие технологии доступны не только жителям столицы, но и населению в регионах. Количество граждан, получивших высокоспециализированную медицинскую помощь в регионах, увеличено практически в 38 раз в сравнении с 2009 годом, причем более 30% составили сельские жители (814 чел. – 2009 г., 30 839 чел. – 2011г.) [3].

Обеспокоенность и повышенное внимание к онкологическим заболеваниям – одна из особенностей современного здравоохранения. Во всем мире отмечается рост заболеваемости от неинфекционных хронических заболеваний, связанный, прежде всего, с ростом социально-экономического благополучия стран, проведением профилактических мероприятий, направленных на выявление онкологических заболеваний. Хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, серьезно влияют на показатель продолжительности жизни, являющийся одним из важнейших индикаторов Глобального индекса конкурентоспособности страны. Онкологические заболевания являются ведущими в структуре хронических неинфекционных заболеваний. Смертность от онкологических заболеваний в Казахстане занимает второе место в структуре смертности населения. Ежегодно в РК от онкологических заболеваний умирает порядка 17000 человек, из которых 42% - лица трудоспособного возраста.

В течение последних пяти лет в Республике Казахстан увеличилось абсолютное число заболевших злокачественными новообразованиями: если в 2006 году было зарегистрировано 28573 заболевших, то к концу 2011 года их число возросло до 30299. Ежегодный прирост числа больных со злокачественными новообразованиями составляет 5%. Показатель смертности от злокачественных

новообразований за последние пять лет снизился на 11,9% с 113,7 на 100 тыс. населения в 2006 году до 101,6 на 100 тыс. населения в 2011 году. Снижение показателя смертности связано, в первую очередь, с улучшением диагностики злокачественных новообразований на ранних стадиях и эффективностью результатов лечения. В то же время, этот показатель все еще не достигает показателей развитых стран [4].

На реализацию Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы будут направлены средства республиканского и местных бюджетов. Это означает, что на приобретения высокотехнологичного оборудования по Программе развития онкологической помощи на 2012 -2016 годы будет инвестировано 9,24% средств от общего объема финансирования. Данная технология с учетом принципа регионализации онкологических организаций и поэтапности оказания онкологической помощи позволит продлить и улучшить качество жизни порядка 3000 пациентов в год, страдающих онкологическими заболеваниями, что составляет 10% от общего числа больных.

На начальном этапе развития в Казахстане находится внутритканевая лучевая терапия (брахитерапия), внедрение которой позволило бы спасти около 1500 жизней в год. Также, ввиду отсутствия оборудования, не применяется такой метод лечения как интраоперационная лучевая терапия, позволяющая улучшить результаты лечения некоторых локализаций (рак молочной железы, желудка, коло ректальный рак) [5].

Общие затраты на реализацию ПРОП составят 207 703 079,6 тыс. тенге, в том числе из средств республиканского бюджета 207 655 079,6 тыс. тенге, из средств местных бюджетов 48 000,0 тыс. тенге (таблица 1) [5].

Таблица 1 – Объем затрат на реализацию Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан

Годы	Финансирование, всего (тыс. тенге)	Республ. бюджет (тыс. тенге)	Местный бюджет (тыс. тенге)
2012.	10 865 225,0	10 817 225,0	48 000,0
2013	56 238 504,5	56 238 504,5	
2014	74 884 513,1	74 884 513,1	
2015	48 399 400,9	48 399 400,9	
2016	17 315 436,1	17 315 436,1	
Итого	207 703 079,6	207 703 079,6	

В структуру онкологической службы Республики Казахстан входят: НИИ онкологии и радиологии (г. Алматы), 17 региональных онкологических диспансеров, 2 отделения при многопрофильных стационарах и 290 онкологических кабинетов в поликлиниках общей лечебной сети. Ведется внедрение методов лечения и диагностики высокотехнологичной лучевой терапии онкологическим больным, что требует оснащения онкологических организаций линейными ускорителями последнего поколения, в том числе путем модернизации существующих.

В рамках реализации Программы развития онкологической помощи Республики Казахстан планируется организация оказания медицинской помощи в высокотехнологичных центрах радиационной онкологии (ВЦРО): создание 5-ти региональных

высокотехнологических центров радиационной онкологии на общую сумму 19,2 млрд. тг. (таблица 2).
Таблица 2 - Высокотехнологические центры радиационной онкологии

Наименование региона	Наименования высокотехнологического медицинского оборудования	Необходимые финансовые средства
г. Алматы (КазНИИОиР)	Линейный ускоритель «TrueBEAM», дооснащение линейного ускорителя «Clinac 600», Система «VERO», аппарат для интраоперационной лучевой терапии, МРТ	8,7 млрд. тг.
г. Астана	Система «VERO», дооснащение 2-х линейных ускорителей, МРТ,	3,6 млрд. тг.
г. Семей	Линейный ускоритель «TrueBEAM», аппарат брахитерапии, МРТ,	2,9 млрд. тг.
г. Актобе	Линейный ускоритель «TrueBEAM», МРТ, КТ	2,6 млрд. тг.
г. Караганда	Дооснащение линейного ускорителя, МРТ, аппарат брахитерапии	1,4 млрд. тг.

Таким образом, разработка и внедрение системы оценки эффективности затрат, методик экономического анализа деятельности субъекта здравоохранения, внедрение ресурсосберегающих технологий является приоритетной и актуальной задачей в развитии медицинской отрасли экономики РК.

Создание 5-и региональных высокотехнологических центров радиационной онкологии на сумму около 19,2 млрд. тенге является рентабельной инвестицией, перспективным проектом включающий все аспекты эффективности (медицинский, социальный, экономический).

Лечение и диагностика онкологических больных с применением высокотехнологических методов приведет к снижению расходов на медицинский туризм граждан РК в страны ближнего и дальнего зарубежья за счет государственных средств из бюджета и даст возможность получать данные медицинские услуги в стране. Это, в свою очередь, послужит развитию инфраструктуры онкологической помощи, научных исследований, вкладу РК в международные усилия по борьбе с онкологическими заболеваниями, прогрессирование кадрового потенциала путем привлечение передовых инновационных методов.

Внедрение высокотехнологических центров радиационной онкологии будет способствовать развитию медицинского туризма, что приведет к притоку иностранных пациентов и дополнительным финансовым потокам, обеспечит возможность онкологическим больным нашей страны получить весь комплекс онкологической помощи, повысить качество оказания онкологической помощи, а в совокупности - улучшить качество жизни онкологических больных и сэкономить государственные средства.

Выводы

В современных условиях развития национальной системы здравоохранения качество оказания медицинских услуг неразрывно связано с экономическим состоянием и целесообразным управлением ресурсов в здравоохранении в целом, и на уровне медицинской организации в частности. В настоящее время в системе здравоохранения РК проводится всеобъемлющая работа

по внедрению инновационных методов, дорогостоящих технологий при реализации отраслевых инвестиционных проектов, в том числе, и в онкологической службе Казахстана.

При реализации инвестиционных проектов необходимо учитывать насыщенность рынка медицинским оборудованием, технологиями, лекарственными средствами, а также высокую волатильность цен и ответственность топ-менеджеров в принятии инвестиционного решения в условиях возрастающей политики децентрализации и автономности субъектов здравоохранения. Это требует глубокого понимания основ инвестиционного анализа, применения принципов междисциплинарного подхода, внедрения государственно-частного партнерства - интеграцию бизнеса и государства.

Список литературы

1. Государственная программа «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы, утвержденная Указом Президента РК от 29 ноября 2010 года № 1113.
2. Послание Президента Республики Казахстана Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства».
3. Аналитическая записка за 2011 год о реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года.
4. Программа развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы, утвержденная, утвержденная Постановлением Правительства РК 29 марта 2012 г. №366.
5. Отчет за 2012г. МЗ РК «О реализации Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы».

Тужырым

М.Е.Мамаев.

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Қазіргі жоғары технологиялық жабдықтар онкологиялық көмектің сапасын бақылау.

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының аясында медициналық көмектің сапасын арттыру үшін инвестициялық жобалар іске асуда.

Қазақстан Республикасында 2012-2016 жылдарға арналған онкологиялық көмектің даму бағдарламасы қабылданды. Бағдарламаны іске асыру барысында бюджеттік мол қаражаттың игерілуі қарастырылған. Соған байланысты тәуекелдерді болжамдау, бағалау, басқару жүйесін, денсаулық сақтау жүйесінің жұмысын экономикалық талдау методикасын енгізу қажет.

Денсаулық сақтау жүйесінде инвестицияның жұмыстың мониторингі, инвестицияның жобаларды басқару белгіленген мақсаттарға жетуде маңызды орын алады.

Түйінді сөздер: онкологиялық көмек, жоғарғы технологиялық жабдық, медициналық технологияны енгізу.

Summary

M.E.Mamaev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

The quality of cancer care in the context of modern high-tech equipment

Realized investment projects in the framework of the State Programme for the Development of Health (SPDH) of the Republic of Kazakhstan (RK) "Salamatty Kazakhstan" for 2011 - 2015 are aimed at improving the quality of medical services.

In the Republic of Kazakhstan adopted a development program for cancer care (PCC) in 2012-2016. During the implementation of PCC planned development of large-scale budget, in connection with what is necessary to introduce

a system of forecasting, risk assessment and management, implementation techniques of economic analysis of the health care system, the transition to a system of control based on the introduction of the principles of continuous improvement in the quality of decision-making (CQI - PDCA).

Monitoring of investment, management of investment projects in the health system of Kazakhstan is an important component of an instrument to achieve the goals described above.

Keywords: cancer care, high-tech equipment, the introduction of medical technology.